РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1197 НА КОМИСИЯТА

от 19 юни 2025 година

за налагане на мярка по Акта за международните обществени поръчки за ограничаване на достъпа на икономическите оператори и медицинските изделия с произход от Китайската народна република до пазара на обществени поръчки за медицински изделия в Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 2022/1031 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2022/1031 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2022 г. относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от трети държави до пазарите на обществени поръчки и концесии на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от Съюза до пазарите на обществени поръчки и концесии на трети държави (Акт за международните обществени поръчки – IPI) ([1]) („Регламента за IPI“), и по-специално член 6, параграф 1 и член 6, параграф 6, буква б) от него,

като има предвид, че:

1. ПРОЦЕДУРА

1.1. Проучване по IPI и консултации

(1) На 24 април 2024 г. Европейската комисия („Комисията“) започна по собствена инициатива проучване съгласно член 5, параграф 1 от „Регламента за IPI“ на мерки и практики на Китайската народна република (КНР), водещи до сериозно и повтарящо се влошаване на достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от Съюза до пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР. За целта Комисията публикува известие в *Официален вестник на Европейския съюз* („известието за започване“) ([2]).

(2) В известието за започване Комисията установи три категории мерки и практики: i) създаващи предпочитание за снабдяването с местни медицински изделия и услуги; ii) ограничаващи снабдяването с вносни стоки, включително медицински изделия, и iii) налагащи условия при централизираното възлагане на поръчки в КНР за медицински изделия, водещи до необичайно ниски оферти, чието равнище е непосилно за дружествата със стопанска цел.

(3) В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламента за IPI Комисията прикани правителството на Китай (ПК) да изрази становището си, да предостави съответната информация и да започне консултации, за да премахне или коригира посочените в известието за започване мерки и практики. Комисията също така изпрати на ПК искане за информация под формата на подробен въпросник. ПК не отговори на този въпросник, но започна консултации с Комисията по смисъла на член 5, параграф 2 от Регламента за IPI, които се проведоха от 24 до 26 юли 2024 г. в Пекин.

([1]) ОВ L 173, 30.6.2022 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1031/oj.

([2]) Известие за започване на проучване съгласно Акта за международните обществени поръчки относно мерките и практиките, прилагани от Китайската народна република на пазара на обществени поръчки за медицински изделия (ОВ C, C/2024/2973, 24.4.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2973/oj).

1.2. **Доклад от проучването**

(4) На 14 януари 2025 г., след приключване на проучването и консултациите с КНР, Комисията предостави на обществеността доклад в съответствие с член 5, параграф 4 от Регламента за IPI, съдържащ констатациите от проучването и предлагания начин на действие ([3]) („доклада от проучването“).

(5) В доклада от проучването Комисията стигна до заключението, че установените в хода на проучването мерки и практики ([4]) („установените мерки и практики“) съществуват, прилагат се на цялата територия на КНР и засягат всички категории медицински изделия по начин, който води до сериозно и повтарящо се влошаване на достъпа на икономическите оператори от Съюза и на произведените в Съюза медицински изделия до пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР. Следователно те представляват мерки или практики на трети държави по смисъла на член 2, параграф 1, буква и) от Регламента за IPI. Комисията отбеляза също така, че ПК не предложи конкретни корективни действия за това сериозно и повтарящо се влошаване на достъпа.

(6) Въз основа на това Комисията предложи да оцени определените в член 6 от Регламента за IPI условия с оглед на приемането на мярка по IPI в съответствие с определението в член 2, параграф 1, буква й) от Регламента за IPI.

(7) Комисията представи доклада от проучването на Европейския парламент и на Съвета съгласно изискването в член 5, параграф 4 от Регламента за IPI съответно на 29 и 30 януари 2025 г.

1.3. **Последваща процедура**

1.3.1. *Обществена консултация относно евентуална мярка по IPI*

(8) На 19 февруари 2025 г. Комисията публикува известие за обществена консултация ([5]), целта на която бе да се информира за мнението на субектите, които потенциално може да бъдат засегнати от евентуални мерки по IPI съгласно член 6 от Регламента за IPI за ограничаване на достъпа на икономическите оператори и медицинските изделия с произход от КНР до пазара на обществени поръчки за медицински изделия в Съюза („обществената консултация“). Комисията получи изявления от няколко субекта. Някои от изявленията се отнасяха за потенциални проблеми с доставките, свързани с определени медицински изделия, и отражението върху бюджета на възлагащите органи и възложителите. Други се отнасяха за потенциалното въздействие на мерките върху икономическите оператори, произвеждащи медицински изделия в КНР, определянето на произхода на стоките и икономическите оператори, както и определянето на стойността на офертите. Някои от субектите поискаха разяснения относно начина на установяване на праговете от 50 %, посочени в член 8, параграф 1 от Регламента за IPI, както и необходимите доказателства, които съответните икономически оператори ще трябва да предоставят. Комисията надлежно взе предвид получените изявления в своята оценка.

1.3.2. *Информиране на държавите членки*

(9) В съответствие с изискването в член 5, параграф 2 от Регламента за IPI Комисията редовно информираше държавите членки за напредъка на проучването и консултациите в рамките на Комитета по въпросите, свързани с пречките пред търговията, създаден по силата на член 7 от Регламент (ЕС) 2015/1843 на Европейския парламент и на Съвета ([6]).

([3]) Доклад на Комисията в съответствие с член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/1031 по отношение на проучването съгласно Акта за международните обществени поръчки относно мерките и практиките, прилагани от Китайската народна република на пазара на обществени поръчки за медицински изделия (COM(2025) 5) и придружаващият го Работен документ на службите на Комисията „Фактически констатации от проучването съгласно Акта за международните обществени поръчки на пазара на обществени поръчки за медицински изделия в Китайската народна република“, придружаващ документа „Доклад на Комисията в съответствие с член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/1031 по отношение на проучването съгласно Акта за международните обществени поръчки относно мерките и практиките, прилагани от Китайската народна република на пазара на обществени поръчки за медицински изделия“ (SWD(2025) 2).

([4]) Вж. раздел II от доклада от проучването и раздели 1 и 2 от работния документ на службите на Комисията (по-специално съображения 1—49).

([5]) Обществена консултация във връзка с възможността за въвеждане на мерки за ограничаване на достъпа на икономически оператори и медицински изделия с произход от Китайската народна република до пазара на обществени поръчки за медицински изделия в ЕС съгласно член 6 от Акта за международните обществени поръчки (ОВ C, C/2025/1259, 19.2.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1259/oj).

([6]) Регламент (ЕС) 2015/1843 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (ОВ L 272, 16.10.2015 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj).

(10) След публикуването на доклада от проучването Комитетът по въпросите, свързани с пречките пред търговията, също получи актуална информация за оценката на определените в член 6 от Регламента за IPI условия с оглед на евентуалното приемане на мярка по IPI в съответствие с определението в член 2, параграф 1, буква й) от Регламента за IPI.

(11) В рамките на оценката на условието, определено в член 6, параграф 3, буква б) от Регламента за IPI, „относно наличието на алтернативни източници на доставка на съответните стоки […], за да се избегне или сведе до минимум значително отрицателно въздействие върху възлагащите органи и възложителите“, Комисията се консултира с държавите членки в рамките на Комитета по въпросите, свързани с пречките пред търговията, за да се увери, че няма зависимости за държавите членки от медицински изделия с произход от КНР.

2. **ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯРКАТА ПО IPI**

(12) В съответствие с член 6, параграф 1 от Регламента за IPI, когато Комисията установи, че е налице мярка или практика на трета държава по смисъла на член 2, параграф 1, буква и), тя приема мярка по IPI посредством акт за изпълнение, ако счете, че това е в интерес на Съюза. В член 6, параграф 2 от Регламента за IPI се уточнява, че мярка по IPI не се приема, когато Комисията стигне до заключението, че приемането на такава мярка не е в интерес на Съюза.

(13) Съгласно член 6, параграф 3 от Регламента за IPI мярката по IPI се определя с оглед на наличната информация и въз основа на два критерия: i) нейната пропорционалност спрямо мярката или практиката на третата държава; и ii) наличието на алтернативни източници на доставки на съответните стоки и услуги, за да се избегне или сведе до минимум значително отрицателно въздействие върху възлагащите органи и възложителите. В съответствие с член 6, параграф 8 от Регламента за IPI Комисията трябва да уточни обхвата на прилагане на мярката по IPI, включително секторите или категориите стоки, специфичните категории на икономическите оператори, както и на възлагащите органи или възложителите, специфичните прагове, до които се прилага мярката по IPI, и когато е подходящо, процентните стойности на приложимата корекция на присъдените точки.

(14) Съгласно член 6, параграф 6 от Регламента за IPI Комисията може да реши, в рамките на обхвата на мярката по IPI, да ограничи достъпа на икономически оператори, стоки или услуги с произход от трета държава до процедурите за възлагане на обществени поръчки в Съюза, като изисква от възлагащите органи или възложителите: или да налагат корекция на присъдените точки за офертите, подадени от икономически оператори с произход от тази трета държава, или да изключват офертите, подадени от такива икономически оператори. В това отношение съгласно член 6, параграф 9 от Регламента за IPI при определянето на мярката по IPI въз основа на тези два варианта Комисията трябва да избере вида мярка, която би била пропорционална и най-ефективно би коригирала степента на влошаване на достъпа за икономическите оператори, стоки или услуги от Съюза до пазарите на обществени поръчки или концесии на трети държави.

(15) С оглед на гореизложеното е необходимо, първо, да се определи мярка по IPI, чийто обхват е пропорционален на установените мерки и практики, и да се избере подходящата форма на мярката от двата налични варианта, посочени в член 6, параграф 6 от Регламента за IPI, която би била пропорционална и най-ефективно би коригирала степента на влошаване на достъпа вследствие на установените мерки и практики; второ, да се оцени наличието на алтернативни източници на доставки, в случай че такава мярка по IPI бъде наложена; и трето, да се прецени дали налагането на тази мярка по IPI би било в интерес на Съюза.

2.1. **Пропорционалност и адекватност на евентуална мярка по IPI по отношение на установените мерки и практики**

2.1.1. *Установените мерки и практики*

(16) В доклада от проучването Комисията представи две основни констатации относно установените мерки и практики.

(17) Първо, Комисията установи, че чрез тези мерки и практики ПК е въвело всеобхватна система от общоприложими преференции за възлагането на поръчки за местни медицински изделия, която значително възпрепятства достъпа на операторите от Съюза и произведените в Съюза медицински изделия до пазара на обществени поръчки в КНР ([7]). Основната характеристика на тази система е наложеното на възложителите правно обвързващо задължение да

([7]) „Анализът на мерките и практиките, предмет на проучването, показва, че чрез тях КНР е въвела многопластова всеобхватна система от общоприложими преференции за възлагането на поръчки за местни медицински изделия, която е довела до системна дискриминация спрямо вносните медицински изделия и чуждестранните икономически оператори, като се изпълнява всеобхватна политика за закупуване на китайски продукти“ (за повече информация вж. раздел V от доклада от проучването).

възлагат поръчки за местни медицински изделия винаги когато те се конкурират с вносни медицински изделия и представляват разумна алтернатива. Дискриминационният характер на това общо задължение се подсилва от обременяващи процедури за одобрение ([8]) при възлагането на поръчки за вносни медицински изделия, които значително ограничават възможността на възложителите да възлагат поръчки за такива изделия. Освен това в тази уредба се отдава предпочитание на вносните медицински изделия, които са свързани с трансфер на технологии към местни дружества ([9]). Системата е допълнително подсилена от специфични за сектора мерки ([10]) под формата на указания на ПК за държавните болници да постигнат конкретни цели за поръчките за няколко категории местни медицински изделия, в които се призовава за пълно изключване на вносните медицински изделия в 137 категории. И накрая високоефективните медицински изделия са посочени в стратегията „Произведено в Китай 2025“ ([11]), вследствие на което за окръжните болници важи указанието да постигнат много високи цели за дела на поръчките за местни медицински изделия от висок клас — 70 % до 2025 г. и 95 % до 2030 г. — с което на практика се ограничават почти напълно възможностите за достъп на вносни продукти до значителна част от китайския пазар на обществени поръчки.

(18) Комисията доказа, че тази всеобхватна система от общоприложими преференции за възлагането на поръчки за местни медицински изделия се прилага на цялата територия на КНР и засяга всички категории медицински изделия.

(19) Чрез анализ на достатъчно представителна извадка от процедури за възлагане на обществени поръчки в КНР ([12]) Комисията установи, че 87 % от процедурите за медицински изделия съдържат изрични и/или имплицитни забрани за възлагане на поръчки за вносни медицински изделия или дискриминационни изисквания, засягащи възлагането на такива поръчки ([13]). При разглеждането на тези процедури стана ясно, че забраните и дискриминационните изисквания се прилагат независимо от стойността на поръчката. Както е установено в придружаващия доклада от проучването работен документ на службите на Комисията, фактът, че закупуването на вносни медицински изделия може да бъде разрешено в рамките на процедура за възлагане на поръчка, не означава непременно, че вносните медицински изделия не са обект на дискриминация, например чрез изисквания за трансфер на технологии ([14]). Освен това дори в случаите, когато възлагането на поръчки за вносни медицински изделия е разрешено, посочените в съображение 17 секторни цели за поръчките за местни изделия създават значително предимство за доставчиците и медицинските изделия с произход от КНР. Поради това Комисията установи, че всеобхватната система от общоприложими преференции за възлагането на поръчки за местни медицински изделия в КНР, която се състои от закони и мерки за изпълнение с общо приложение, засяга целия пазар на обществени поръчки за медицински изделия

([8]) Когато не са налице местни стоки или такива не може да бъдат придобити в КНР при разумни търговски условия, възлагането на поръчки за вносни стоки подлежи на специална процедура за оценка и одобрение, предвидена в Административните мерки за възлагане на поръчки за вносни стоки. Предоставеното от местните финансови служби одобрение се основава на оценката на експертна група за това дали има произведени в КНР стоки с технически спецификации и функционално използване, сравними с тези на вносните стоки (за повече подробности вж. раздел 2.1.2 от работния документ на службите на Комисията, съображения 19—27).

([9]) „В член 5 от Административните мерки се определя принципът, че закупуването на вносни стоки следва да „благоприятства местните иновации или възприемането и усвояването на основни технологии от местните предприятия“, и се изисква „да се даде предимство на закупуването на стоки, с което се осъществява трансфер на технологии“ или „се предоставят услуги за обучение и други компенсаторни търговски мерки“. Съгласно член 15 това предимство трябва да бъде посочено в документацията за обществената поръчка за закупуването на вносните стоки“ (вж. съображение 20 от работния документ на службите на Комисията).

([10]) „В документ 551 се определят изисквания към всички местни органи да увеличат поръчките за местни стоки за 178 категории медицински изделия. Целевият дял на местните медицински изделия варира между 25 % и 100 %, като за 137 категории медицински изделия целта е 100 %“ (вж. съображение 28 от работния документ на службите на Комисията).

([11]) „В „Технологичната пътна карта за ключовите области от стратегията „Произведено в Китай 2025“ („Пътната карта на MIC“), в която са заложени цели за всеки посочен в MIC 2025 отрасъл, се определят конкретни цели за дела на закупуваните от окръжните болници местни медицински изделия от висок клас, който следва да достигне 50 % до 2020 г., 70 % до 2025 г. и 95 % до 2030 г.““ (вж. съображение 6 от работния документ на службите на Комисията).

([12]) Извадката се състоеше от 35 504 процедури, които съдържаха в публично достъпен формат минимално необходимите документи, които да дадат възможност да се установят критериите за допустимост и другите условия за участие на потенциалните оференти, и поради беше възможно те да бъдат надлежно разгледани за целите на проучването (вж. раздел 2.3, съображение 51 от работния документ на службите на Комисията).

([13]) Вж. раздел V от доклада от проучването, стр. 10, и раздел 2.3.1, съображение 54 от работния документ на службите на Комисията.

([14]) „Действително, при възлагането на поръчки за вносни медицински изделия има дискриминация дори ако възлагането на такива поръчки е одобрено, доколкото с член 5 от Административните мерки се дават указания на възложителите да „дават предимство на закупуването на продукти, с които се осъществява трансфер на технологии […], предоставят се услуги за обучение и други компенсаторни търговски мерки““ (вж. раздел 2.3, съображение 55 от работния документ на службите на Комисията).

в КНР независимо от стойността на обществената поръчка. Комисията съответно заключи в своя доклад от проучването, че тези мерки и практики водят до сериозно и повтарящо се влошаване на достъпа на икономическите оператори от Съюза и произведените в Съюза медицински изделия до пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР.

(20) Второ, Комисията установи, че прилаганото от ПК основано на обема възлагане на поръчки за медицински изделия също води до значително и повтарящо се влошаване на достъпа на операторите от Съюза и на произведените в Съюза медицински изделия до пазара на обществени поръчки в КНР ([15]). Действително, организирането на това основано на обема възлагане на поръчки кара доставчиците да подават изключително ниски оферти, за да изпълнят критериите за подбор и да спечелят поръчки, което води до значителни намаления на цените, които в дългосрочен план са непосилни за дружествата със стопанска цел, които не могат да разчитат на държавна подкрепа. Ограничителният ефект на тази система за основано на обема възлагане на поръчки може да бъде допълнително засилен чрез държавна подкрепа за производителите с производствени и научноизследователски и развойни дейности в КНР, особено когато тази подкрепа е конкретно свързана със спечелването на основани на обема поръчки. В доклада от проучването се посочва, че „специфичната организация на основаното на обема възлагане на поръчки в КНР създава за вносните медицински изделия и за чуждестранните икономически оператори значителни затруднения и води до фактическа дискриминация и ограничаване, или дори до изключване на внасящите медицински изделия чуждестранни оператори, както и на вносните медицински изделия, които се конкурират в тези процедури за основано на обема възлагане на поръчки ([16]) и се стига до заключението, че практическата организация на основаното на обема възлагане на поръчки за медицински изделия в КНР води до сериозно и повтарящо се влошаване на достъпа на операторите от Съюза и произведените в Съюза медицински изделия до пазара на обществени поръчки в КНР по смисъла на член 2, параграф 1, буква и) от Регламента за ІРІ“ ([17]).

2.1.2. *Пропорционалност на евентуалната мярка по ІРІ*

(21) Всеобхватната система от общоприложими преференции за възлагането на поръчки за местни медицински изделия в КНР засяга всички медицински изделия с произход от Съюза, без да се прилага какъвто и да е праг и независимо дали те се предлагат от оференти от Съюза, от местни оференти или от други чуждестранни оференти. Освен това тази система съдържа обременяващи процедури за одобрение при възлагането на поръчки за вносни медицински изделия и налага специфични за сектора цели за възлагането на поръчки за медицински изделия с произход от КНР. Както е обяснено в съображения (17)—(19) по-горе, Комисията заключи в своя доклад от проучването, че прилагането на тази система е довело до сериозно и повтарящо се влошаване на достъпа на икономическите оператори от Съюза и произведените в Съюза медицински изделия до пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР. Действително, Комисията установи, че 87 % от процедурите за медицински изделия съдържат изрични и/или имплицитни забрани за възлагане на поръчки за вносни медицински изделия или дискриминационни изисквания, засягащи възлагането на такива поръчки ([18]), което до голяма степен води до затваряне на пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР.

(22) Съгласно член 6, параграф 4 от Регламента за ІРІ дадена мярка по ІРІ може да се прилага само за процедурите за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност, която за стоките е равна на или по-голяма от 5 000 000 EUR без ДДС. Поради това изключването на всички икономически оператори с произход от КНР от всички процедури на Съюза за възлагане на обществени поръчки на стойност, равна на или по-голяма от 5 000 000 EUR без ДДС, за всички категории медицински изделия би било най-всеобхватната възможна мярка по ІРІ, която Комисията може да приеме за този сектор съгласно Регламента за ІРІ ([19]). Комисията разгледа въпроса дали тази мярка по ІРІ би била пропорционална по отношение на установените мерки и практики.

(23) Според данните в Електронния ежедневник за поръчките (TED) ([20]), по отношение на медицинските изделия процедурите за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност, равна на или по-голяма от 5 000 000 EUR без ДДС, представляват около 59 % от общия пазар на обществени поръчки за медицински изделия в Съюза. Освен това съгласно член 6, параграф 8 и член 8, параграф 1 от Регламента за ІРІ всяка мярка по ІРІ би могла да засегне доставката на медицински изделия с произход от КНР само в максимален размер от 50 % от общата стойност на поръчката независимо от произхода на оферента. Освен това, за разлика от прилаганата от КНР система, при мярка по

([15]) Вж. раздел V от доклада от проучването.
([16]) Вж. раздел V от доклада от проучването, стр. 11.
([17]) Вж. бележка под линия 16.
([18]) Вж. бележка под линия 13.
([19]) Тъй като Регламентът за ІРІ не ограничава възможния обхват на дадена мярка по ІРІ до разследвания сектор в съответната трета държава, в този случай Комисията има право да приеме мярка по ІРІ, която да обхваща други сектори или комбинация от сектори, включително този на медицинските изделия. Въпреки това Комисията реши да ограничи мярката по ІРІ само до сектора на медицинските изделия, като се има предвид, че в Съюза се внася значителен обем медицински изделия с произход от КНР (над 6 млрд. EUR, вж. съображение 40). Комисията счита, че такава целенасочена мярка ще окаже достатъчно въздействие в област от стратегически интерес за КНР.
([20]) https://ted.europa.eu/bg/

IPI не би имало изисквания за допълнителни ограничения, например обременяващи процедури за одобрение при възлагането на поръчки за медицински изделия от КНР или налагане на специфични за сектора цели за възлагането на поръчки за медицински изделия с произход от Съюза.

(24) Като се вземат предвид всички посочени в съображения (17)—(23) елементи, обхватът и потенциалният изключващ ефект на най-всеобхватната възможна мярка по IPI в сектора на медицинските изделия във всички случаи биха били по-ограничени от обхвата и установения изключващ ефект на въведената от КНР всеобхватна система от общоприложими преференции за възлагането на поръчки за местни медицински изделия.

(25) Разликата между въздействието на най-всеобхватната възможна мярка по IPI, която може да бъде приета в този сектор съгласно Регламента за IPI, и въздействието на установените мерки и практики се увеличава допълнително от ограничителния ефект на мерките и практиките, свързани с основаното на обема възлагане на поръчки в КНР. Поради това е целесъобразно в обхвата на най-всеобхватната възможна мярка по IPI да се включи и възлагането на поръчки в Съюза за стоките, за които се прилага основано на обема възлагане на поръчки в Китай.

(26) С оглед на гореизложеното мярка по IPI, която включва в своя обхват: i) всички процедури за възлагане на обществени поръчки в Съюза за всички категории медицински изделия, ii) организирани от всички възлагащи органи и възложители от Съюза, iii) на стойност, равна на или по-голяма от 5 000 000 EUR без ДДС ([21]), и iv) засягащи всички икономически оператори с произход от КНР, може да се счита за пропорционална по отношение на установените мерки и практики, въведени и прилагани от ПК.

(27) За целите на прилагането на всяка мярка по IPI произходът на икономическите оператори и стоките се определя в съответствие с член 3 от Регламента за IPI и допълнителните разяснения на Комисията в нейните „Насоки за улесняване на прилагането на Регламента за IPI от възлагащите органи и възложителите, както и от икономическите оператори“ („Насоките“) ([22]). В Насоките също така се предоставят разяснения относно задълженията на спечелилите оференти.

2.1.3. *Форма на евентуалната мярка по IPI, която би била пропорционална и най-ефективно би коригирала установената степен на влошаване на достъпа*

(28) Както е посочено в съображение (14), двете възможни форми на мярка по IPI са или корекция на присъдените точки за офертите, подадени от икономически оператори с произход от КНР, или изключване на офертите, подадени от такива икономически оператори.

(29) Както е посочено в съображение (20), в доклада от проучването Комисията стигна до заключението, че „установените в хода на проучването мерки и практики, въведени от КНР по отношение на възлагането на поръчки за медицински изделия, съществуват и се прилагат на цялата територия на КНР. Те засягат всички категории медицински изделия по начин, който води до сериозно и повтарящо се влошаване на достъпа на икономическите оператори от Съюза и произведените в Съюза медицински изделия до пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР“ ([23]). Комисията също така констатира, че установените мерки и практики най-често водят до изключването на икономическите оператори и стоките в сектора на медицинските изделия с произход от чужди държави, включително тези от Съюза ([24]), което съответно в голяма степен означава затваряне на пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР.

([21]) Съответните прогнозни стойности на поръчките следва да се изчисляват в съответствие с член 5 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).

([22]) Съобщение на Комисията — „Насоки за улесняване на прилагането на Регламента за IPI от възлагащите органи и възложителите, както и от икономическите оператори“ (ОВ C 64, 21.2.2023 г., стр. 7).

([23]) Вж. раздел VI от доклада от проучването.

([24]) Вж. раздел V от доклада от проучването и раздел 2.3 от работния документ на службите на Комисията, в които Комисията установи, че 87 % от процедурите за медицински изделия съдържат изрични и/или имплицитни забрани за възлагане на поръчки за вносни медицински изделия или дискриминационни изисквания, засягащи възлагането на такива поръчки.

(30) Като се имат предвид степента на дискриминационните и изключващите характеристики на установените мерки и практики, както и значителната степен на изключване на икономическите оператори и стоките от Съюза, до която те водят, налагането на корекция на присъдените точки за офертите, подадени от икономически оператори с произход от КНР ([25]), би имало само ограничен ефект и във всеки случай не би коригирало по ефективен начин установената степен на влошаване на достъпа. Действително, съгласно член 6, параграфи 7 и 8 от Регламента за IPI тази форма на мярка по IPI би могла да засегне оценката и класирането на офертите само до известна степен (до 50 %) за процедурите за възлагане на поръчки, които се основават на най-доброто съотношение между цената и качеството, и евентуално до 100 % за основаните само на цената оферти. Поради това мярка по IPI под формата на корекция на присъдените точки би включвала различни варианти за степента, в която икономическите оператори и медицинските изделия с произход от КНР да могат да бъдат изключени от пазара на обществени поръчки в Съюза, тъй като тя не би позволила на възлагащите органи и възложителите систематично да изключват операторите с произход от КНР. Следователно тя не би коригирала влошаването на достъпа на икономическите оператори и медицинските изделия от Съюза, изразяващо се в установеното им изключване в КНР.

(31) Поради това мярка по IPI под формата на корекция на присъдените точки не би коригирала по най-ефективен начин установеното ниво на влошаване на достъпа в съответствие с изискването в член 6, параграф 9 от Регламента за IPI.

(32) Комисията смята, че мярка по IPI под формата на изключване на офертите, подадени от икономически оператори с произход от КНР ([26]), би била по-подходяща в този случай. Тя би била пропорционална и най-ефективно би коригирала установеното влошаване на достъпа, тъй като би постигнала във възможно най-голяма степен изключващия ефект на установените мерки и практики.

2.1.4. *Заключение относно мярката по IPI*

(33) С оглед на гореизложеното мярка по IPI под формата на изключване на офертите, подадени от икономически оператори с произход от КНР, по смисъла на член 6, параграф 6, буква б) от Регламента за IPI, която включва в своя обхват: i) всички процедури за възлагане на обществени поръчки в Съюза за всички категории медицински изделия, ii) организирани от всички възлагащи органи и възложители от Съюза, iii) на стойност, равна на или по-голяма от 5 000 000 EUR без ДДС, и iv) засягащи всички икономически оператори с произход от КНР, се счита за подходяща и пропорционална по отношение на установените мерки и практики, въведени и прилагани от ПК, и най-ефективно би коригирала установената степен на влошаване на достъпа.

2.2. **Наличие на алтернативни източници на доставки**

(34) Мярка по IPI, изключваща офертите, подадени от икономически оператори с произход от КНР, няма да окаже въздействие върху наличните източници на доставки за процедурите за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност под 5 000 000 EUR без ДДС, тъй като съгласно член 6, параграф 4 от Регламента за IPI тези процедури са изключени от обхвата на прилагане на всяка мярка по IPI. Около 96 % от всички процедури на Съюза за възлагане на обществени поръчки за медицински изделия, регистрирани в TED за периода 2017—2022 г. ([27]), включват стойности под този праг и представляват около 41 % от общата стойност на всички регистрирани процедури за възлагане на обществени поръчки. Това означава, че възлагащите органи и възложителите от Съюза няма да понесат отрицателни последици в повечето процедури за възлагане на обществени поръчки, които ще организират след налагането на евентуална мярка по IPI в сектора на медицинските изделия, и че почти половината от разходите им за медицински изделия ще останат незасегнати от тази мярка по IPI.

(35) За процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност, равна на или по-голяма от прага от 5 000 000 EUR без ДДС, е възможно да се твърди, че мярка по IPI, изключваща офертите, подадени от всички икономически оператори с произход от КНР, на теория може да намали цялостния избор на наличните медицински изделия и да окаже въздействие върху техните цени. Тези потенциални отрицателни последици обаче биха били смекчени от няколко фактора.

(36) Първо, оферентите с произход извън КНР все пак ще може да подават оферти, включващи медицински изделия с произход от КНР, при условие че стойността на доставяните медицински изделия с произход от КНР не е по-голяма от 50 % от общата стойност на поръчката ([28]). Следователно медицинските изделия с произход от КНР ще продължат да се предлагат в процедурите на Съюза за възлагане на обществени поръчки.

([25]) Съгласно член 6, параграф 6, буква а) от Регламента за IPI.
([26]) Съгласно член 6, параграф 6, буква б) от Регламента за IPI.
([27]) Последната година, за която Комисията разполага с изчерпателни данни в TED.
([28]) В съответствие с член 8, параграф 1 от Регламента за IPI.

(37) Второ, в случаите, когато само оференти с произход от КНР биха били в състояние да отговорят на изискванията по процедурите или биха били единствените, които са в състояние да предложат конкретни медицински изделия, необходими по свързани с обществения интерес наложителни причини, изключенията по член 9, параграф 1 от Регламента за IPI все пак ще позволят на възлагащите органи и възложителите от Съюза да не прилагат мярката по IPI, като по този начин ще се предотврати каквото и да било намаляване на наличните източници на доставки в тези ситуации.

(38) Трето, информацията, която Комисията получи от държавите членки след искането си за установяване на възможни зависимости от медицински изделия с произход от КНР в техните процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с посоченото в съображение (11), не показва да съществуват такива зависимости в която и да е категория медицински изделия.

(39) Четвърто, Комисията установи, че съществуват достатъчно алтернативни източници на доставки. Съюзът има значителен търговски излишък с останалата част от света в сектора на медицинските изделия, оценен на над 19 млрд. EUR през 2023 г., ([29]) което предполага, че износът може да бъде пренасочен към пазара на Съюза в отговор на евентуално намаление на доставките на китайски медицински изделия. Освен това обемът на засегнатите от мярката по IPI медицински изделия би могъл да бъде компенсиран с увеличено производство на медицински изделия в Съюза или с увеличен обем на вноса от други трети държави, като Обединеното кралство, Швейцария, Съединените щати и Япония ([30]).

(40) През 2023 г. Съюзът е внесъл от КНР медицински изделия на стойност около 6,2 млрд. EUR. През същата година той е изнесъл за останалата част от света медицински изделия на стойност над 69 млрд. EUR. Следователно на съвкупно равнище производителите на медицински изделия от Съюза вече разполагат с нетен производствен капацитет, който е повече от десет пъти по-голям от вноса в Съюза на медицински изделия от КНР. Съюзът също така е внесъл медицински изделия на стойност над 49 млрд. EUR от търговски партньори, различни от КНР, което показва, че Съюзът вече разполага с диверсифицирани източници на доставки.

(41) Освен това не целият внос в Съюза на медицински изделия с произход от КНР би попаднал в обхвата на мярката по IPI. Публично достъпни данни от промишлеността на Съюза показват, че обществените поръчки представляват едва 50—70 % от общия пазар на медицински изделия в Съюза. Ако се приеме, че обществените поръчки за медицински изделия с произход от КНР ще са с подобен дял (т.е. между 3 и 4,5 млрд. EUR), в съчетание с факта, че 41 % от процедурите на Съюза за възлагане на обществени поръчки за медицински изделия няма да подлежат на мярката по IPI ([31]), стойността на медицинските изделия с произход от КНР, за която потенциално ще трябва да бъдат използвани алтернативни източници на доставки, би била много по-малка от общата стойност на вноса в Съюза на медицински изделия от КНР.

(42) Освен това подробният анализ на Комисията относно наличието на източници на доставки за всички категории медицински изделия (на ниво шестцифрен код по ХС за всички медицински изделия), с помощта на описаните по-горе параметри, показва, че производителите на медицински изделия от Съюза разполагат с необходимия капацитет, за да осигурят алтернативни източници на доставки. По-специално производителите от Съюза ще трябва да пренасочат едва 3—4 % от настоящия си износ, за да заменят всички внасяни от КНР медицински изделия, които евентуално ще бъдат изключени от процедурите на Съюза за възлагане на обществени поръчки. Въз основа на този анализ Комисията установи, че възлагащите органи и възложителите от Съюза ще разполагат с голямо разнообразие от алтернативни източници на доставка (както за медицински изделия от Съюза, така и за вносни медицински изделия) за всички категории медицински изделия, които да заменят медицинските изделия с произход от КНР, които биха били засегнати от мярката по IPI. В заключение, приемането на определената в съображение (33) мярка по IPI няма да създаде недостиг или значително да намали доставките на медицински изделия за възлагащите органи и възложителите от Съюза, тъй като Съюзът все още ще разполага с алтернативни източници на доставки, които биха били достатъчни, за да се отговори на търсенето посредством обществени поръчки.

([29]) *Източник*: Евростат (https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home).

([30]) Според последните търговски статистически данни на Евростат за снабдяването с медицински изделия Съюзът е внесъл медицински изделия в размер на 49 млрд. EUR от трети държави, различни от КНР, както е посочено в съображение 40.

([31]) Тъй като те биха попаднали под прага от 5 000 000 EUR без ДДС, определен в член 6, параграф 4 от Регламента за IPI.

2.3. **Интерес на Съюза**

(43) С член 6, параграф 2 от Регламента за IPI се изисква преценката за това дали е в интерес на Съюза да приеме мярка по IPI да се основава на отчитане на различните интереси в тяхната цялост, включително на интересите на икономическите оператори от Съюза.

(44) Освен това в съображение 20 от Регламента за IPI се пояснява, че Комисията следва да оцени последиците от приемането на мярка по IPI спрямо нейното въздействие върху по-широките интереси на Съюза, като обърне специално внимание на общата цел за постигане на реципрочност чрез отваряне на засегнатия пазар на съответната трета държава и подобряване на възможностите за достъп до пазара за икономическите оператори от Съюза. Също така следва да се отчете и целта за ограничаване на ненужната административна тежест за възлагащите органи и възложителите, както и за икономическите оператори.

(45) Въз основа на това в настоящия случай е целесъобразно да се оцени първо — икономическият интерес на производителите от Съюза, второ — възможното въздействие върху възлагащите органи и възложителите от Съюза, и трето — цялостното въздействие на мярката по IPI върху икономиката на Съюза. След това Комисията ще трябва да оцени последиците от мярката по IPI спрямо по-широките интереси на Съюза, като вземе предвид общата цел за постигане на реципрочност чрез отваряне на пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР и подобряване на възможностите за достъп до този пазар за икономическите оператори от Съюза.

2.3.1. *Интерес на икономическите оператори от Съюза*

(46) Както е посочено в съображение (39), Съюзът има значителен търговски излишък с останалата част от света в сектора на медицинските изделия, което показва, че производителите от Съюза имат силна конкурентна позиция в световен мащаб в този сектор и значителна производствена база. Стойността на пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР може да бъде оценен на приблизително 128 млрд. EUR ([32]). Премахването на дискриминационните пречки на този пазар би предоставило значителни възможности за растеж за икономическите оператори от Съюза. Приемането на мярката по IPI би оказало въздействие върху ПК, което да го убеди да премахне дискриминационните пречки, съответно създавайки в по-голяма степен еднакви условия на конкуренция на голям международен пазар, което ще бъде от полза за икономическите оператори от Съюза.

(47) Освен това Комисията не установи значителни отрицателни последици от мярката по IPI за икономическите оператори от Съюза.

(48) Действително, следва да се припомни, че анализът на наличните данни в TED показва, че общата стойност на процедурите на Съюза за възлагане на обществени поръчки за медицински изделия с прогнозна стойност, равна на или по-голяма от 5 000 000 EUR без ДДС, и следователно в обхвата на мярката по IPI, съответства на около 59 % от общата стойност на всички процедури за възлагане на обществени поръчки за медицински изделия, отчетени в тази база данни за периода 2017—2022 г. Тъй като обществените поръчки представляват 50—70 % от общото потребление на медицински изделия в Съюза и няма причина да се смята, че съотношението между обществените и частните поръчки е различно за медицинските изделия с произход от КНР, може да се изчисли, че при консервативен сценарий изключването на икономическите оператори с произход от КНР от обхванатите от мярката по IPI процедури за възлагане на обществени поръчки, в комбинация с важащото за целия срок на съответната поръчка задължение за спечелилите оференти да не предлагат медицински изделия с произход от КНР на стойност над 50 % от общата стойност на поръчката, би могло да доведе до намаляване на вноса на медицински изделия с произход от КНР с 15—20 % годишно ([33]). Това би представлявало 1—1,2 млрд. EUR годишно от общия внос на медицински изделия с произход от КНР в размер на 6,2 млрд. EUR ([34]).

([32]) За 2023 г. общият китайски пазар на медицински изделия бе оценен на 160 млрд. EUR. Въпреки че няма налични данни за точната обща стойност на пазара на обществени поръчки, държавните болници са представлявали 83,5 % от общия брой посещения на пациенти в цялата държава през същата година. Това ясно показва, че делът на пазара на обществени поръчки в стойността на пазара на медицински изделия може да бъде оценен на около 80 %, т.е. 128 млрд. EUR.

([33]) Консервативната прогноза се основава на следните параметри: i) стойността на вноса в Съюза на медицински изделия с произход от КНР (6,2 млрд. EUR); ii) делът на публичните разходи на пазара на Съюза за медицински изделия (50—70 %); iii) делът на процедурите за възлагане на обществени поръчки за медицински изделия с прогнозна стойност над прага за прилагане на мярката по IPI от общата стойност на обществените поръчки (около 59 %); и iv) изискването за максимална стойност от 50 % по отношение на медицинските изделия със съответния произход във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка със стойност над прага за прилагане на мярката по IPI.

([34]) Мащабът на очакваните за производителите от Съюза нови пазарни възможности може да бъде изчислен само въз основа на официални статистически данни за търговията поради липсата на преки данни на ниво предприятие за общата стойност на медицинските изделия с произход от КНР, предназначени за продажба чрез обществени поръчки в Съюза.

(49) Като се има предвид силната конкурентна позиция в световен мащаб на производителите от Съюза и наличието на пазара на Съюза на медицински изделия от други големи държави износителки, ако в конкретен случай възлагащите органи и възложителите не могат да възложат поръчки за медицински изделия с произход от КНР поради мярката по ІРІ, те биха могли вместо това да възложат поръчки за медицински изделия, които се произвеждат в Съюза или са с произход от други трети държави. Въз основа на оценки на отрасъла по отношение на размера на пазара на медицински изделия в Съюза и стойността на внесените от трети държави медицински изделия, настоящият пазарен дял на медицинските изделия от Съюза от общото потребление на медицински изделия в Съюза се оценява на приблизително 60 %. Ако се допусне, че пазарният дял на потенциално засегнатите от мярката по ІРІ медицински изделия с произход от КНР (т.е. 1—1,2 млрд. EUR) ще бъде разпределен между медицинските изделия от Съюза и внесените от други трети държави медицински изделия пропорционално на настоящите пазарни дялове, производителите на медицински изделия от Съюза потенциално биха могли да спечелят около 60 % от обема на обществените поръчки, които при липсата на мярката по ІРІ биха били за изделия с произход от КНР.

(50) Може да се очаква, че тези нови възможности на пазара на обществени поръчки в Съюза при прилагане на мярката по ІРІ ще бъдат достъпни за всички производители на медицински изделия в Съюза. Според публично достъпни данни от сдружения на промишлеността на Съюза съществуват над 30 000 предприятия от Съюза, от които около 90 % са малки и средни предприятия ([35]).

(51) Комисията също така оцени въздействието на мярката по ІРІ върху някои вносители от Съюза на медицински изделия, които се снабдяват с такива продукти в КНР, включително икономически оператори от Съюза, които произвеждат медицински изделия в КНР и ги внасят в Съюза, тъй като след налагането на мярката по ІРІ продажбите им на медицински изделия с произход от КНР може да намалеят. В това отношение Комисията разгледа коментарите на субектите, които предоставиха информация вследствие на обществената консултация относно евентуалната мярка по ІРІ, и стигна до заключението, че потенциалното отрицателно въздействие на мярката по ІРІ върху такива оператори също би било ограничено. Първо, около 96 % от всички процедури на Съюза за възлагане на обществени поръчки за медицински изделия биха попаднали извън обхвата на мярката по ІРІ, което представлява приблизително 41 % от общата стойност на обществените поръчки за медицински изделия в Съюза. Второ, в съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Регламента за ІРІ тези вносители все пак ще могат да продават 50 % от обема на внасяните от тях от КНР и засегнати от мярката по ІРІ медицински изделия. Като се има предвид, че обществените поръчки за медицински изделия представляват 50—70 % от общия пазар на Съюза за медицински изделия, може да се изчисли, че засегнатите вносители от Съюза биха могли да запазят повече от 80 % от настоящия си обем на вноса от КНР ([36]). И накрая, всички такива потенциални отрицателни икономически последици за вносителите на засегнати от мярката по ІРІ медицински изделия биха били компенсирани от по-широките интереси на Съюза, по-специално общата цел да бъде оказано въздействие върху КНР, за да отвори своя пазар на обществени поръчки за медицински изделия по реципрочен начин и да осигури еднакви условия на конкуренция за всички оператори от Съюза в сектора на медицинските изделия.

2.3.2. *Интерес на възлагащите органи и възложителите от Съюза*

(52) Комисията извърши задълбочена оценка на наличието на източници на доставки за всички категории медицински изделия в случай на всеобхватна мярка по ІРІ, обхващаща всички категории и подкатегории медицински изделия. Както е подробно описано в раздел 2.2 по-горе, не се очаква мярката по ІРІ да намали наличието на източници на доставки за медицински изделия за възлагащите органи и възложителите от Съюза, което беше допълнително потвърдено от резултатите от консултациите с държавите членки в рамките на Комитета по въпросите, свързани с пречките пред търговията, относно евентуални зависимости от медицински изделия с произход от КНР. Във всеки случай, както е обяснено в съображение (37), в случаите, когато само оференти с произход от КНР биха били в състояние да отговорят на изискванията по процедурите или биха били единствените, които са в състояние да предложат конкретни медицински изделия, необходими по свързани с обществения интерес наложителни причини, възлагащите органи и възложителите от Съюза ще имат право да не прилагат мярката по ІРІ в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламента за ІРІ.

(53) Освен това, тъй като приблизително 96 % от всички процедури на Съюза за възлагане на обществени поръчки биха останали извън обхвата на мярката по ІРІ, може да се очаква, че административната тежест за възложителите би била ниска.

([35]) medtech-europe--facts-figures-2024.pdf.

([36]) Прогнозата е съобразена с очакваното намаление на вноса на медицински изделия с произход от КНР, което представлява 1—1,2 млрд. EUR годишно (вж. съображение 48) и близо 20 % от регистрирания през 2023 г. общ внос на медицински изделия с произход от КНР в размер на 6,2 млрд. EUR.

(54) Комисията оцени евентуалното неблагоприятно въздействие на ограниченията по отношение на възлагането на обществени поръчки за медицински изделия с произход от КНР върху публичните бюджети. Въз основа на наличната понастоящем информация и като се има предвид, че държавите членки не съобщиха за каквото и да било очаквано значително въздействие върху своите бюджети, Комисията смята, че отражението върху бюджетите за възлагащите органи и възложителите би останало ограничено. Освен това пазарът на медицински изделия в Съюза е много конкурентен с широк кръг алтернативни доставчици (както местни, така и чуждестранни). Като се има предвид тази силна конкуренция, Комисията смята, че въпреки изключването на икономическите оператори с произход от КНР от ограничен брой процедури за възлагане на поръчки, на пазара на Съюза би имало достатъчно предлагане на медицински изделия на достъпни цени.

(55) В резултат на това може да се очаква цялостното въздействие на мярката по IPI върху възлагащите органи и възложителите от Съюза да остане ограничено.

2.3.3. *Интерес от гледна точка на икономиката на Съюза*

(56) Установените мерки и практики, въведени и прилагани от КНР, причиниха значителни вреди на производителите на медицински изделия от Съюза, които осигуряват приблизително 700 000 работни места в Съюза ([37]). Въздействието, което мярката по IPI би могла да окаже, за да се премахнат дискриминационните пречки на пазара на обществени поръчки за медицински изделия в КНР и да се коригира сериозното и повтарящо се влошаване на достъпа за икономическите оператори от Съюза, може да помогне на производителите от Съюза и съответно за създаването на допълнителни работни места в сектора. Дори в случай че тези пречки не бъдат премахнати, Комисията изчисли, че очакваното заместване на вноса от КНР с произвеждани в Съюза медицински изделия би запазило съществуващите работни места в сектора и потенциално би могло да генерира над 3 000 нови работни места в Съюза ([38]). Поради това се очаква сега налаганата мярка по IPI да окаже като цяло положително въздействие върху съвкупното промишлено производство на Съюза.

2.3.4. *По-широките интереси на Съюза*

(57) Чрез ограничаването на достъпа на икономически оператори с произход от КНР до пазара на обществени поръчки в Съюза мярката по IPI би могла да послужи като стимул за КНР да премахне своите ограничителни и дискриминационни мерки и практики спрямо икономическите оператори и медицинските изделия от Съюза и така да отвори своя пазар на обществени поръчки по реципрочен начин. Като се има предвид потенциалното намаляване на вноса от КНР в Съюза след налагането на мярката по IPI, в съчетание със стратегическото значение на сектора на медицинските изделия за КНР при преследването на целта на държавата да стане водещ износител в този сектор, налагането на мярката по IPI би могло да окаже необходимото въздействие, за да бъдат подобрени възможностите за достъп до този пазар за икономическите оператори и стоките от Съюза. Очакваното въздействие от мярката по IPI би било в съответствие и с по-широките интереси на Съюза за насърчаване на отворените и справедливи пазари на обществени поръчки, като същевременно се подкрепя конкурентоспособността на промишлеността на Съюза.

(58) Комисията смята, че установените ограничени отрицателни последици от мярката по IPI не биха надвишили по значение тези широки интереси, по-специално с оглед на очакваното ѝ положително въздействие върху сектора на медицинските изделия в Съюза, което може частично да компенсира сериозното и повтарящо се влошаване на достъпа на операторите от Съюза до пазара на медицински изделия в КНР.

(59) С оглед на гореизложеното Комисията смята, че е в интерес на Съюза да наложи тази мярка по IPI.

([37]) medtech-europe--facts-figures-2024.pdf.

([38]) Тази прогноза се основава на допускането в съображение 49, че „производителите на медицински изделия от Съюза потенциално биха могли да спечелят около 60 % от обема на обществените поръчки, които при липсата на мярката по IPI биха били за изделия с произход от КНР“ (т.е. 60 % от 1—1,2 млрд. EUR), и на оценката за производителността на нието лице в Съюза, която за 2024 г. е 177 000 EUR (*източник*: medtech-europe--facts-figures-2024.pdf).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(60) С оглед на гореизложените съображения и в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламента за IPI Комисията следва да наложи посочената в съображение (33) мярка по IPI.

(61) Мярката по IPI следва да се прилага при процедурите за всички категории медицински изделия съгласно кодове от 33100000-1 до 33199000-1 по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), определени в Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета ([39]).

(62) За да се улесни прилагането на мярката по IPI от възлагащите органи и възложителите от Съюза, както и от икономическите оператори, е целесъобразно да се предвиди разумен срок от 10 дни между деня на публикуване на мярката по IPI в *Официален вестник на Европейския съюз* и деня на влизането ѝ в сила.

(63) В съответствие с член 11, параграф 1 от Регламента за IPI Комисията беше подпомагана при приемането на мярката по IPI от Комитета по въпросите, свързани с пречките пред търговията, който е комитет по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ([40]).

(64) Предвидената в настоящия регламент мярка по IPI е в съответствие със становището на Комитета по въпросите, свързани с пречките пред търговията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Налага се мярка по Акта за международните обществени поръчки („мярка по IPI“) под формата на изключване на офертите, подадени от всички икономически оператори с произход от Китайската народна република, по смисъла на член 6, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2022/1031, за всички процедури за възлагане на обществени поръчки в Съюза, които са с предмет доставката на медицински изделия, попадащи в кодове по CPV от 33100000-1 до 33199000-1, определени в Регламент (ЕО) № 2195/2002, и са с прогнозна стойност, равна на или по-голяма от 5 000 000 EUR без ДДС.

2. Посочената в параграф 1 мярка по IPI се прилага за всички възлагащи органи и възложители от Съюза, без да се засяга член 7 от Регламент (ЕС) 2022/1031.

Член 2

1. Възлагащите органи и възложителите от Съюза, както и спечелилите оференти, са длъжни да спазват определените в член 8 от Регламент (ЕС) 2022/1031 изисквания по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, попадащи в обхвата на посочената в параграф 1 от член 1 мярка по IPI.

([39]) Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/oj).

([40]) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

2. Възлагащите органи и възложителите от Съюза са длъжни:

а) да определят произхода на икономическите оператори и медицинските изделия, които може да попадат в обхвата на мярката по IPI, в съответствие с критериите съответно по член 3 от Регламент (ЕС) 2022/1031 и член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета ([41]);

б) да изчисляват съответните прогнозни стойности на поръчките в съответствие с член 5 от Директива 2014/24/ЕС.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на десетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

([41]) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12).